Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Паротидэктомия

Частичное или полное удаление околоушной слюнной железы (расположенной перед ухом)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Правая ☐ Левая

Планируемый объём: ☐ Поверхностная ☐ Частичная / экстракапсулярная ☐ Тотальная ☐ Будет определён во время операции _____

Мониторинг лицевого нерва: ☐ Будет использоваться ☐ Не будет использоваться

Предварительный диагноз (результат тонкоигольной биопсии / визуализации): _____

Заранее согласованное решение на случай, если опухоль затрагивает лицевой нерв: ☐ При необходимости ветвь нерва может быть пожертвована ☐ Сохранить нерв ☐ Другое _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Околоушная (паротидная) железа — самая крупная слюнная железа. Она расположена с каждой стороны перед ухом и чуть ниже него. Через железу проходит и внутри неё делится на ветви **лицевой нерв**, который приводит в движение мимические мышцы лица. Поэтому операция на околоушной железе — это тонкое вмешательство, при котором особое внимание уделяется сохранению этого нерва.

Паротидэктомию чаще всего выполняют по поводу **образования (опухоли)** в железе. Подавляющее большинство таких образований (около 80%) — **доброкачественные (не рак)**; наиболее частые из них — плеоморфная аденома и опухоль Уортина. Доброкачественные образования тоже могут со временем расти, а

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

некоторые из них (особенно плеоморфная аденома) спустя многие годы могут перерождаться в злокачественные. Реже операция требуется при повторяющихся воспалениях, камнях или злокачественной опухоли.

Цель операции — полностью удалить образование или поражённую ткань железы, **сохранив лицевой нерв**, и установить окончательный диагноз с помощью патогистологического исследования.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общим наркозом в условиях операционной. До операции образование оценивают с помощью УЗИ, МРТ и/или тонкоигольной биопсии; эти исследования дают полезную предварительную информацию, но окончательный диагноз ставится после операции по результатам патогистологического исследования.

1. **Разрез:** Разрез обычно начинается в естественной складке перед ухом, огибает мочку уха снизу и продолжается в кожную складку на шее. В подходящих случаях разрез можно сделать короче или скрыть его по линии роста волос.
2. **Поиск лицевого нерва:** Кожу и ткани над железой приподнимают и находят основной ствол лицевого нерва. Если используется аппарат **мониторинга нерва**, он помогает отслеживать расположение и функцию нерва на протяжении всей операции.
3. **Удаление образования/железы:** Тщательно прослеживая нерв и его ветви, образование удаляют вместе с участком здоровой ткани железы вокруг него. В зависимости от расположения и размера образования может быть удалена только наружная часть железы (поверхностная паротидэктомия), её часть или вся железа (тотальная паротидэктомия).
4. **Патогистологическое исследование:** Удалённую ткань отправляют на патогистологическое исследование. Окончательный результат обычно готов в течение 1–2 недель.
5. **Завершение операции:** Проводится остановка кровотечения, и обычно устанавливается тонкий **дренаж** (трубка) для отвода скапливающейся крови или жидкости. Кожу зашивают тонкими швами; может быть наложена лёгкая давящая повязка.

Если опухоль окружает лицевой нерв или прорастает в него (это происходит в основном при злокачественных опухолях), для полного удаления опухоли может потребоваться пожертвовать ветвью нерва или всем нервом. Эта возможность **отдельно обсуждается с вами** до операции. Нерв не будет пересечён неожиданно, без предварительного обсуждения с вами; что будет сделано, если опухоль не удастся отделить от нерва, согласовывается с вами заранее.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз	Около 2–4 часов	Обычно 1–2 ночи; выписка после удаления дренажа

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Удаление образования и установление окончательного диагноза
- Предотвращение роста доброкачественного образования, давления на лицевой нерв и, в долгосрочной перспективе, его перерождения в злокачественное
- При злокачественных опухолях — первый и самый важный этап лечения
- Прекращение боли и отёков, вызванных повторяющимся воспалением или камнями

При большинстве доброкачественных опухолей операция обеспечивает стойкое излечение. При плеоморфных аденомах, удалённых по правильной методике, частота рецидива составляет **менее 1–2 случаев на 100 пациентов**; однако разрыв капсулы опухоли или ранее перенесённая операция повышают этот показатель. Опухоль Уортина может появиться в виде нового очага в той же или в противоположной железе. При злокачественных опухолях результат зависит от вида и стадии опухоли, и может потребоваться дополнительное лечение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4 Другие варианты лечения

- **Наблюдение:** При некоторых небольших образованиях, которые считаются доброкачественными (например, при опухоли Уортина у пожилых пациентов или у пациентов с высоким операционным риском), может обсуждаться регулярное наблюдение с помощью УЗИ/МРТ. В этом случае образование остаётся на месте и может расти, а окончательный диагноз поставить нельзя.
- **Медикаментозное лечение:** При воспалении или камнях — антибиотики, обильное питьё, массаж; в подходящих случаях — удаление камней с помощью эндоскопии слюнного протока (сиалоэндоскопии). При опухолях медикаментозное лечение не является вариантом.
- **Лучевая терапия:** Применяется при злокачественных опухолях, которые невозможно прооперировать, или в дополнение к операции; при доброкачественных опухолях она не является предпочтительным методом лечения.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Без операции образование остаётся на месте, и окончательный диагноз поставить нельзя. Доброкачественные опухоли обычно растут медленно, но со временем они могут увеличиться, что затрудняет операцию и повышает риск для лицевого нерва; плеоморфные аденомы спустя многие годы могут перерождаться в злокачественные (примерно в 5–10% случаев за годы). Злокачественная опухоль без лечения будет прогрессировать и может распространиться на окружающие ткани и лимфатические узлы.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией выполняются анализы крови, визуализирующие исследования (УЗИ/МРТ) и при необходимости тонкоигольная биопсия; вас осмотрит анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (пожалуйста, следуйте указаниям анестезиолога).
- У мужчин в день операции могут подстричь бороду в зоне разреза и волосы вокруг уха. В зависимости от разреза могут немного подровнять волосы за ухом.
- Перед операцией осматривают и фотографируют ваши мимические движения, чтобы зафиксировать, как они работают до операции.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24–48 часов	В области операции будут ощущаться стянутость, лёгкая или умеренная боль и отёк, которые контролируются обезболивающими. Дренаж обычно удаляют на 1–2-й день,

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	когда количество отделяемой жидкости уменьшается. Рекомендуется спать с приподнятой головой. Будут проверяться движения мышц вашего лица.
1-я неделя	После выписки вы можете вернуться к повседневным делам. Швы обычно снимают на **5–7-й день**. Заметно онемение мочки уха и области перед ухом. Результат патогистологического исследования обычно бывает готов в этот период или вскоре после него, и его сообщат вам.
2–6-я недели	Большинство людей возвращаются к сидячей работе в течение 1–2 недель. Интенсивные физические нагрузки и работу, связанную с наклонами и подъёмом тяжестей, следует отложить примерно на **2–3 недели**. Если возникла временная слабость мышц лица, она обычно начинает проходить в течение нескольких недель; рекомендуются защита глаза и упражнения для мышц лица.
3–12-й месяцы	Рубец постепенно светлеет. Онемение мочки уха частично проходит. Большинство пациентов с временной слабостью нерва полностью восстанавливаются в течение 6–12 месяцев. Потливость щеки во время еды (синдром Фрея), если она возникает, может появиться в этот период.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Боль, стянутость и отёк в области операции
- Онемение мочки уха и кожи перед ухом
- Рубец в месте разреза (со временем светлеет)
- Лёгкая боль на стороне операции при открывании рта или жевании (в первые дни)

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Временная слабость лицевого нерва** — Примерно у **10–40 из 100** пациентов (в зависимости от объёма удалённой ткани и расположения образования) возникает временная слабость в углу рта, при закрывании глаза или при поднимании брови. Обычно она затрагивает только одну ветвь и **проходит в течение нескольких недель или месяцев**. Если в этот период глаз закрывается не полностью, для предотвращения сухости глаза вам потребуется использовать капли, гель и ночную повязку на глаз.
- **Стойкое снижение чувствительности мочки уха** — Нерв, обеспечивающий чувствительность мочки уха (большой ушной нерв), затрагивается при большинстве операций. У большинства пациентов онемение со временем уменьшается, однако некоторое снижение чувствительности мочки уха и окружающей области может остаться **навсегда**. Обычно это не влияет на повседневную жизнь.
- **Синдром Фрея (потливость во время еды)** — Потливость и покраснение щеки на стороне операции во время еды. Хотя при специальных тестах это выявляется чаще, заметным оно бывает примерно у **10–20 из 100** пациентов и обычно начинается спустя несколько месяцев. Если это беспокоит, можно применять кремы-антиперспиранты или инъекции **ботулотоксина**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Западение в области щеки** — В зависимости от объёма удалённой ткани может сформироваться небольшое углубление перед ухом и разница между двумя сторонами. Если оно заметно, его можно исправить с помощью собственного жира или филлера.

Нечастые состояния

- **Скопление жидкости (серома) или слюны (сиалоцеле) / слюнной свищ** — Примерно у **5–10 из 100** пациентов в области операции может скапливаться жидкость или слюна; в редких случаях она подтекает наружу через кожу (свищ). Обычно это проходит в течение нескольких недель после откачивания иглой, наложения давящей повязки и при необходимости введения ботулотоксина.
- **Кровотечение и гематома** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов под кожей может скопиться кровь. Если гематома большая, может потребоваться её удаление и остановка кровотечения в операционной.
- **Раневая инфекция** — Возникает у **1–3 из 100** пациентов; обычно проходит при лечении антибиотиками, в редких случаях требуется дренирование.
- **Синдром первого укуса** — Особенно после операций на глубокой доле — резкая боль в области угла нижней челюсти, длящаяся несколько секунд, при первых укусах во время еды. Обычно со временем она ослабевает.
- **Рецидив образования** — Хотя при доброкачественных опухолях это бывает нечасто, образование может появиться снова в той же области, а при опухоли Уортина может развиться новый очаг; это может потребовать повторной операции. При повторных операциях риск для лицевого нерва выше.
- **Грубый рубец или келоид** — В зависимости от индивидуальной предрасположенности рубец может утолщаться; можно применять инъекции стероидов или другие методы лечения рубцов.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Стойкий паралич лицевого нерва** — При доброкачественных опухолях при первой операции примерно у **1–3 из 100** пациентов может остаться стойкая слабость одной ветви лицевого нерва или, в редких случаях, всего нерва. Это может привести к опущению угла рта, неполному закрыванию глаза, асимметричной улыбке и сухости глаза; если глаз не защищать, возможно повреждение прозрачной передней оболочки глаза (роговицы) и потеря зрения. Риск выше при злокачественных опухолях, повторных операциях и образованиях, сращённых с нервом. Если развивается стойкий паралич, может потребоваться дополнительное лечение, например препараты для защиты глаза, установка грузика в веко, восстановление нерва или операции по реанимации лица.
- **Окончательный патогистологический диагноз отличается от предварительного** — Даже если дооперационные исследования указывают на доброкачественное образование, окончательное патогистологическое заключение может выявить **злокачественную** опухоль. В этом случае может потребоваться дополнительная операция (удаление оставшейся части железы или лимфатических узлов шеи), лучевая терапия или другие виды лечения.
- **Большая гематома шеи с нарушением проходимости дыхательных путей** — Очень редко быстро увеличивающееся скопление крови может сдавливать шею и вызывать затруднение глотания или дыхания. Это неотложное состояние: гематому необходимо немедленно удалить в операционной, а в редких случаях может потребоваться обеспечение проходимости дыхательных путей (интубация или трахеостомия).
- **Нарушение кровоснабжения кожи** — Расхождение краёв раны, особенно под мочкой уха, из-за ухудшения кровоснабжения кожи; чаще встречается у курящих.
- **Изменение формы мочки уха или нарушение чувствительности ушной раковины** — Встречается редко; связано с разрезом или с воздействием на нерв.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Быстро нарастающий отёк шеи или щеки**, особенно с затруднением глотания или дыхания (неотложное состояние — звоните 112)
- **Непрекращающееся кровотечение** из дренажа или раны
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающее покраснение, боль, ощущение жара или гнойное отделяемое из раны
- **Новая или нарастающая слабость** мимических движений
- Если вы не можете полностью закрыть глаз: **покраснение, ощущение песка, боль или затуманивание зрения** в глазу
- **Подтекание прозрачной жидкости** из раны или мягкая припухлость перед ухом, которая продолжает увеличиваться

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 48 часов держите рану сухой; после этого можно принять короткий тёплый душ, как вам объяснят.
- В первые недели отказ от очень кислой пищи и продуктов, сильно усиливающих слюноотделение, может снизить риск скопления жидкости.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Если есть слабость лицевого нерва, днём используйте капли «искусственная слеза», а на ночь — гель для глаз и повязку на глаз; защищайте глаз от ветра и пыли.
- Защищайте рубец от солнца не менее 6 месяцев (солнцезащитный крем с высоким фактором защиты).
- Обязательно обсудите с врачом результат патогистологического исследования и план дальнейшего наблюдения; регулярные контрольные осмотры рекомендуются даже при доброкачественных опухолях.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что взаимоотношение лицевого нерва и образования можно достоверно увидеть только во время операции, что окончательный диагноз будет поставлен после операции по результатам патогистологического исследования и что в зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение.
- ☐ До операции со мной обсудили, что будет сделано с нервом, если опухоль прорастает в лицевой нерв, и моё решение записано в разделе сведений о пациенте.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.